

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD ·
COLOMBIA

Calidad en salud: *¿norma o realidad?*

Análisis del SOGC y de sus cuatro componentes a la luz del
Decreto 1011 de 2006

Yina Vanessa Cadena Mantilla

Fundamento en Calidad en Salud · Especialización en Gerencia y Auditoría de la
Calidad en Salud · UNIMINUTO · 2026

01

Habilitación

02

PAMEC

03

Información

04

Acreditación

INTRODUCCIÓN

Entre la norma y la realidad

Desde 2006 Colombia cuenta con el **Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC)**, que define cómo se genera, mantiene y mejora la calidad de los servicios de salud (Decreto 1011, 2006).

Aun así, usuarios y profesionales siguen percibiendo barreras de acceso, demoras y fallas en la seguridad de la atención.

Esta presentación recorre los **cuatro componentes** del SOGC, su aplicación en cada **actor** del sistema y una **propuesta** para acercar la norma a la práctica.



PREGUNTA PROBLEMA

A pesar de contar con un marco legal robusto, ¿por qué persisten las brechas en la calidad del servicio de salud en Colombia?

Marco normativo de la calidad en salud

1993 Ley 100 Crea el SGSSS y ordena garantizar la calidad.	2006 Decreto 1011 Establece el SOGC y sus cuatro componentes.	2015 Ley 1751 Estatutaria: la salud como derecho fundamental.	2016 Decreto 780 Compila el Decreto 1011 en el Decreto Único.	2016 Res. 256 Sistema de Información para la Calidad.	2018 Res. 5095 Manual de Acreditación, versión 3.1.	2019 Res. 3100 Inscripción de prestadores y habilitación.
--	---	---	---	---	---	---



El Decreto 1011 de 2006 hoy está compilado en el **Decreto 780 de 2016** (Libro 2, Parte 5, Título 1): sus reglas sobre calidad siguen vigentes.

CONCEPTO

¿Qué es el SOGC?

«Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país».

(Decreto 1011, 2006, art. 2)

Aplica a: prestadores de servicios de salud, EPS y demás entidades administradoras de planes de beneficios, entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada y entidades territoriales de salud.

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD (ART. 3)

-  **Accesibilidad:** usar los servicios que garantiza el SGSSS.
-  **Oportunidad:** recibir la atención sin retrasos que pongan en riesgo la vida o la salud.
-  **Seguridad:** procesos que minimizan el riesgo de eventos adversos.
-  **Pertinencia:** recibir lo que se requiere según la evidencia científica.
-  **Continuidad:** una secuencia lógica de intervenciones, sin interrupciones.

Cuatro componentes, un solo sistema

01

Sistema Único de Habilitación

Obligatorio

Verifica las condiciones mínimas para entrar y permanecer en el sistema.

Res. 3100 de 2019

02

Auditoría para el Mejoramiento (PAMEC)

Obligatorio

Compara la calidad observada con la esperada y corrige las brechas.

Pautas de auditoría ·
MinSalud

03

Sistema de Información para la Calidad

Obligatorio

Mide indicadores y orienta decisiones informadas de usuarios y entidades.

Res. 256 de 2016

04

Sistema Único de Acreditación

Voluntario

Reconoce niveles superiores de calidad en quienes lo solicitan.

Res. 5095 de 2018

Sistema Único de Habilitación

Registra, verifica y controla las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad técnico-administrativa para que un prestador **entre y permanezca** en el sistema (Decreto 1011, 2006).

- 1 **Autoevaluación** de los estándares por el prestador
- 2 **Inscripción** en el REPS (vigencia de 4 años)
- 3 **Verificación** por la secretaría de salud
- 4 **Servicio habilitado** y bajo vigilancia

7 ESTÁNDARES (MINSALUD, 2019)

 Talento humano	 Infraestructura
 Dotación	 Medicamentos, dispositivos e insumos
 Procesos prioritarios	 Historia clínica y registros
 Interdependencia	 Sin habilitación, no se presta

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad

Mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la **calidad observada** frente a la **calidad esperada** (Decreto 1011, 2006).

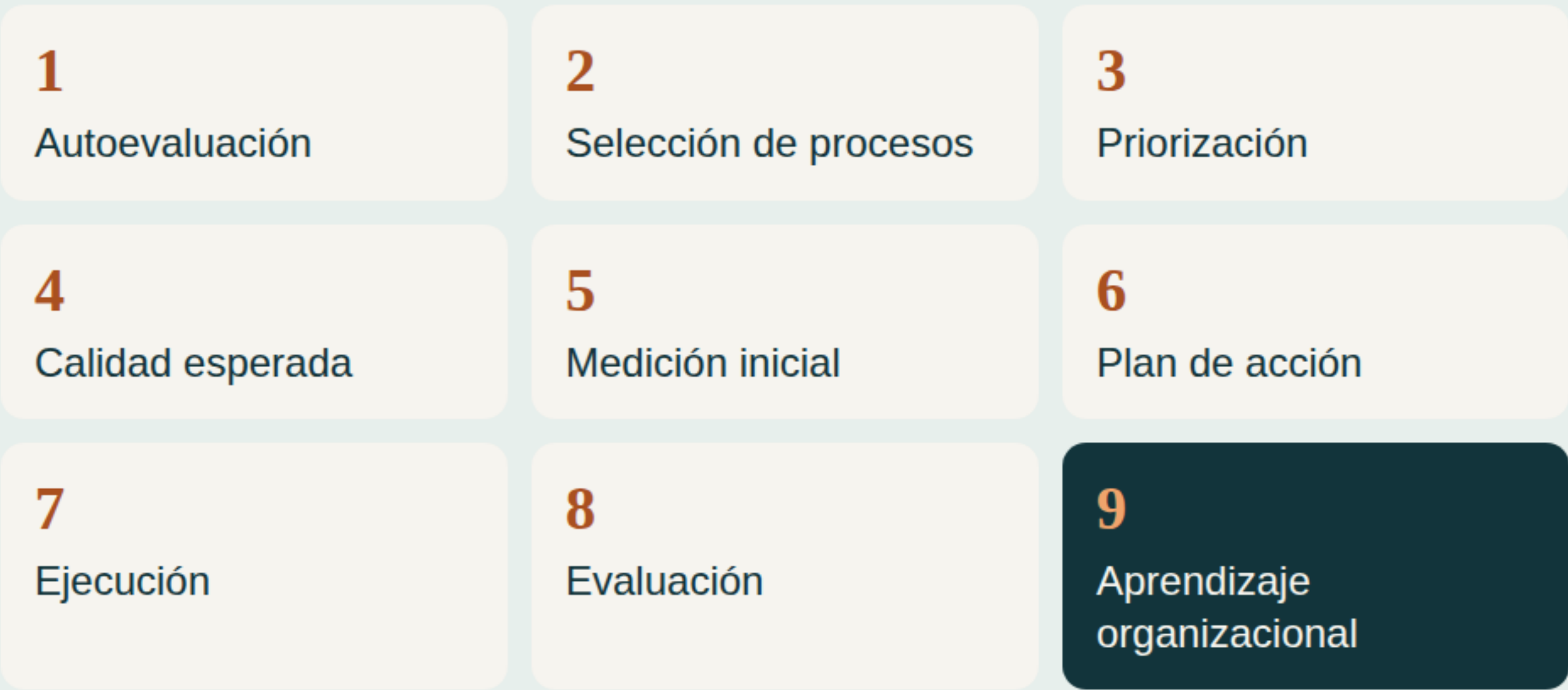
Niveles de operación

- Autocontrol
- Auditoría interna
- Auditoría externa

Tipos de acciones

- Preventivas
- De seguimiento
- Coyunturales

RUTA CRÍTICA DEL PAMEC



Sistema de Información para la Calidad



Monitorear

Hacer seguimiento a la calidad de los servicios.



Orientar

Informar a los usuarios para que elijan con criterio.



Referenciar

Comparar el desempeño entre EPS, IPS y territorios.



Estimular

Impulsar la búsqueda permanente del mejoramiento.

DOMINIOS DE INDICADORES · RES. 256 DE 2016

Efectividad

Seguridad

Experiencia de la atención

Gestión del riesgo

IPS · EPS · entes
territoriales



MinSalud ·
Observatorio de
Calidad



Usuarios y
decisores

Sistema Único de Acreditación

Procesos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa para demostrar el cumplimiento de **niveles superiores de calidad** (Decreto 1011, 2006).

Carácter

Voluntario y periódico

Entidad acreditadora

ICONTEC

Estándares

Manual versión 3.1 (Res. 5095, 2018)

Enfoque

Mejoramiento continuo institucional

EJES DEL MANUAL 3.1

- ✓ Atención centrada en el usuario
- ✓ Gestión clínica excelente y segura
- ✓ Humanización de la atención
- ✓ Gestión del riesgo
- ✓ Gestión de la tecnología
- ✓ Transformación cultural
- ✓ Responsabilidad social

MinSalud y entes territoriales

Ministerio de Salud · rector

Habilitación: expide los estándares y administra el REPS.

PAMEC: emite las pautas indicativas de auditoría.

Información: define indicadores y publica resultados.

Acreditación: reglamenta el sistema y sus manuales.

Entes territoriales

Habilitación: reciben inscripciones y verifican en visita.

PAMEC: implementan el propio y asisten a su red.

Información: consolidan y reportan datos del territorio.

IVC: inspeccionan y sancionan a prestadores.

 **Superintendencia Nacional de Salud:** ejerce inspección, vigilancia y control sobre EPS, IPS y entes territoriales, y puede intervenirlos.

EPS e IPS

EPS · aseguradoras

Habilitación: contratan solo con prestadores habilitados.

PAMEC: auditan la calidad que reciben sus afiliados.

Información: reportan oportunidad, satisfacción y riesgo.

Acreditación: pueden acreditarse como aseguradoras.

IPS · prestadores

Habilitación: autoevalúan e inscriben cada servicio.

PAMEC: aplican la ruta crítica de mejoramiento.

Información: miden y reportan sus indicadores.

Acreditación: buscan estándares superiores.

 **Ejemplo · laboratorio clínico:** habilitación, PAMEC y control de calidad interno y externo se articulan para dar resultados confiables (Tangarife-Castaño y Montoya-Delgado, 2023).

Usuarios: el centro del sistema



Derechos

La salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable (Ley 1751, 2015).



Información

Consultan indicadores de calidad para elegir EPS e IPS con criterio.



Participación

Asociaciones de usuarios, PQRS y veedurías alimentan el mejoramiento.

En un Estado social de derecho, la calidad debe llegar a toda la población, incluida la migrante, como condición de integración y dignidad.

A partir de Clavijo Cáceres y Yáñez Ibarra (2024)

RESPUESTA AL PROBLEMA CENTRAL

¿Por qué persisten las brechas?



Cumplimiento formal

Habilitación y PAMEC se viven como trámite documental.



Crisis financiera

Deudas entre EPS e IPS limitan la inversión en calidad.



Vigilancia débil

Secretarías con poco personal para verificar y hacer seguimiento.



Inequidad territorial

Zonas rurales con menos oferta habilitada y talento humano.



Información subutilizada

Subregistro y poca difusión de indicadores entre usuarios.



Acreditación marginal

Voluntaria y costosa: pocas instituciones la alcanzan.



La brecha está en la **implementación**, la **financiación** y la **cultura organizacional**.

El SOGC es el piso común de calidad del sistema. La tarea pendiente es llevarlo de la norma a la práctica.

Protege al usuario

Fija mínimos de seguridad para que nadie preste servicios sin condiciones.

Ordena el mejoramiento

Convierte la calidad en un ciclo medible, con metas y responsables.

Hace visible el desempeño

Permite comparar, exigir y decidir con datos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Seis apuestas para cerrar la brecha

1 **Habilitación por resultados** MinSalud
Verificar desenlaces y seguridad del paciente, no solo documentos.

2 **Vigilancia territorial fuerte** Entes · Supersalud
Más verificadores capacitados y seguimiento con herramientas digitales.

3 **Incentivos a la calidad** EPS · IPS
Contratos con pago por resultados y reconocimiento a la acreditación.

4 **Información abierta y útil** MinSalud
Tableros públicos y comprensibles de indicadores por EPS e IPS.

5 **Cultura y talento humano** IPS · EPS
PAMEC liderado por la alta dirección y formación continua en calidad.

6 **Usuarios que exigen** Usuarios
Fortalecer asociaciones y PQRS como insumo obligatorio del PAMEC.

CIERRE

Conclusiones y posición crítica

- 1** El SOGC es un marco completo: va del mínimo obligatorio (habilitación) a la excelencia voluntaria (acreditación).
- 2** Las brechas persisten porque la implementación es desigual, la financiación es frágil y la cultura de calidad sigue siendo formalista.
- 3** Cada actor tiene un rol definido; cuando uno falla, como la vigilancia territorial o el flujo de recursos, se debilita toda la cadena.
- 4** Colombia necesita cumplir y medir resultados reales en salud, más que expedir nuevas normas.



La norma es el punto de partida. La realidad cambia cuando cada actor asume la calidad como una responsabilidad propia, y no como un requisito para la próxima visita de verificación.

Referencias

Clavijo Cáceres, D., y Yáñez Ibarra, J. D. (2024). El concepto de la integración del migrante en el estado social de derecho. *Pensamiento Jurídico*, (59), 15–28.

Congreso de la República de Colombia. (1993, 23 de diciembre). *Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2015, 16 de febrero). *Ley Estatutaria 1751 de 2015: por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud*.

Ministerio de la Protección Social. (2006, 3 de abril). *Decreto 1011 de 2006: por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del SGSSS*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *Decreto 780 de 2016: Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *Resolución 256 de 2016: disposiciones sobre el Sistema de Información para la Calidad e indicadores para el monitoreo de la calidad en salud*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). *Resolución 5095 de 2018: Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 3.1*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019, 25 de noviembre). *Resolución 3100 de 2019: Manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud* (pp. 70–100).

Tangarife-Castaño, V. J., y Montoya-Delgado, A. M. (2023). Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud: aplicación al laboratorio clínico. *Medicina & Laboratorio*, 27(2), 1–17.